

MUERTE EN DOMICILIO

Álvaro González de Diego, Silvia García Martínez, Valentin Riaño Zalbidea

INTRODUCCIÓN

Según la definición de la OMS, los cuidados paliativos son un enfoque de asistencia que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, la evaluación impecable y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.

Todo enfermo terminal, tiene derecho a recibir un cuidado paliativo apropiado. Así mismo, estos cuidados deben facilitarse en el lugar que elija el paciente.

Son muchos los factores que influyen en las preferencias del paciente en lo que respecta al lugar de manejo en los últimos días de su vida, así como de su muerte: patología, situación personal, social y familiar, lugar de residencia y disponibilidad de soporte asistencial sanitario. Es fundamental una buena comunicación, informando al paciente de las posibles dificultades del manejo en casa, de cara a que su decisión sea sopesada y razonada.

ASISTENCIA Y MUERTE EN DOMICILIO

Datos epidemiológicos

El 90% del último año de vida de los pacientes con cáncer transcurre en su domicilio. Les aporta seguridad, se sienten todavía “las personas de siempre”, y disfrutan de más autonomía y normalidad. Así mismo, pueden ser atendidos por su equipo de atención primaria habitual y pasan más tiempo con su familia y entorno.

Eligen más su casa: los residentes en zonas rurales, los que económicamente se pueden permitir un cuidado terminal particular, si el cuidador primario es la esposa.

Requisitos para una adecuada asistencia domiciliaria:

- Voluntad del paciente.
- Entorno familiar capaz de asumir cuidados y con voluntad.
- Situación económica adecuada.
- Comunicación positiva (enfermo-profesionales-familia).
- Competencia científico-técnica del equipo de cuidados paliativos.
- Soporte psicosocial adecuado (para paciente y familia).

Preparación, organización y recursos a movilizar:

- Visita domiciliaria: Favorece el conocimiento del paciente y su familia, así como el de sus sentimientos. Mejora su relación con el equipo sanitario y ayuda a valorar el grado de adaptación.
- Información: El paciente tiene derecho a saber y a no saber su diagnóstico y su pronóstico. Así mismo, él decide cuánto desea saber. El enfermo no siempre quiere conocer su evolución, y sin embargo, agradece saber que no tendrá dolor, y que será bien cuidado. Por otro lado, la familia sí puede querer conocer los posibles cursos evolutivos, para anticiparse en los síntomas que vayan apareciendo y ser capaces de abordarlos de forma correcta y más tranquila. Es positivo que los familiares conozcan la opinión del enfermo para respetar su

voluntad.

- Cuidador principal:
 - Formación: Empoderar al cuidador en la enfermedad del paciente, los cuidados, el uso de medicación (especialmente los rescates), reevaluar los síntomas, cómo actuar en emergencias, cómo pedir ayuda sanitaria.
 - “La carpeta del paciente”: recoge datos sobre la identificación personal, familia y amigos, número de seguridad social y seguros, información sanitaria (informes, medicación, teléfono de médico y enfermería), necesidades, documento de voluntades anticipadas, arreglos finales.
 - Autocuidado y autoprotección. Apoyo social para evitar que “se queme” (turnos con familiares, centros de día, auxiliares a domicilio...).
- Soporte social: Instrumentos para facilitar el cuidado y manejo (camas articuladas, grúas...), asistencia domiciliaria subvencionada...
- Soporte sanitario: Los equipos de cuidados paliativos son multidisciplinarios, estando integrados en todos los casos por médicos y enfermería. A pesar de que las fórmulas organizativas puedan variar de una comunidad autónoma a otra, en general, toman parte el Equipo de Atención Primaria, Hospitalización a domicilio, y las Unidades de Cuidados Paliativos (a domicilio o ambulatorios). La actuación es coordinada. Resulta útil y muy tranquilizador, la existencia de un teléfono de contacto para resolución de dudas.
 - Actitud proactiva (anticiparse).
 - Revisar tratamientos, adecuando el esfuerzo terapéutico a la situación clínica en cada momento. Así, mientras que anticoagulantes, antibióticos, antihipertensivos... son prescindibles en situación de terminalidad, analgésicos, antieméticos, sedantes y ansiolíticos, son esenciales al final de la vida.
 - Valorar el nivel de comprensión del cuidador de cada pauta dada.

Otras cuestiones

- Deseos cambiantes: Si el paciente o la familia cambian de opinión respecto al lugar de manejo o fallecimiento, se debe facilitar el ingreso.
- En la fase final, el paciente tiende al sueño. Sólo necesita conocer que se le aprecia y que no será abandonado. Procurar un ambiente de acompañamiento en silencio, agradable y tranquilo es de gran ayuda.

Posibles problemas

- Ansiedad, por verse incapaz de aportar cuidados, resolver emergencias, y no encontrar ayuda próxima. Claudicación familiar.
- Administración de medicación por personas no entrenadas.
- Opiofobia.
- Posibilidad de mayor conspiración del silencio.
- Formación sanitaria deficitaria.
- Escasos recursos sociales.

LA VÍA SUBCUTÁNEA

Definición

La vía subcutánea (SC) consiste en la administración de fármacos y/o líquidos a través de la hipodermis o tejido sc. La hipodermocclisis hace referencia a la hidratación por vía sc.

La vía sc supone una alternativa en el paciente paliativo, en el que la vía oral y la intravenosa

pueden resultar complicadas (náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, agonía, difícil acceso venoso...). En este contexto, es ideal para el manejo domiciliario del enfermo en situación de final de vida.

Indicaciones

- Hidratación.
- Administración de medicación: analgesia, sedantes, antieméticos, esteroides, neurolépticos.

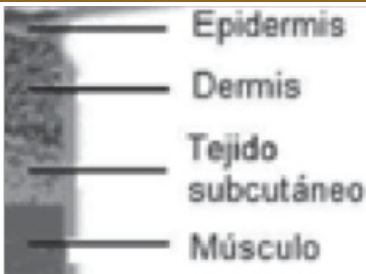
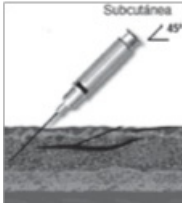
Contraindicaciones

- Incisión quirúrgica local. Disección de ganglios inguinales.
- Superficies radiadas (vasos linfáticos destruidos menor capacidad de absorción, sobre todo de grandes volúmenes e infusiones prolongadas). Zonas cutáneas dañadas (infección, úlceras, infiltración tumoral...).
- Estados edematosos (anasarca, hipoalbuminemia...).
- Necesidad de reposición rápida de volumen (shock).

Tipos de administración

Infusión continua	Infusión en bolos
Infusores o bombas: a) Infusores elastoméricos (balón). b) Bomba mecánica (de jeringa, o resorte). c) Bomba electrónica (peristáltico). Duración (24h, hasta 5-7días).	a) Aguja sc (administración única). b) Palomilla sc (administración en bolos de forma continuada).
Volumen: 0,5-1,5L/24h (1 punto de infusión).3L/24h (2puntos). (Hidratación)	
Ritmo infusión y volumen: Infusores según fabricante; bombas según orden médica. (Medicación).	Evitar volúmenes superiores a 2ml por bolo. (Medicación). Lavado con 0,2-0,5ml suero fisiológico 0,9% (garantizar dosis pauta).
Concentración uniforme y efecto constante.	Efecto en picos (riesgo de reaparecer síntomas antes de la siguiente dosis).
Permite mezclar fármacos.	Permite administración pauta y puntual (rescate, agudo), así como la administración por familia en domicilio.
Limita la movilidad del paciente.	
Mayor coste (infusores/bombas).	Mayor manipulación.

Lugar de inserción y material empleado

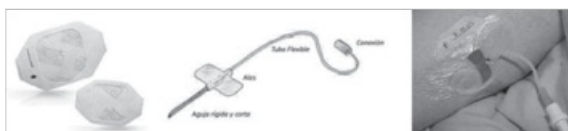


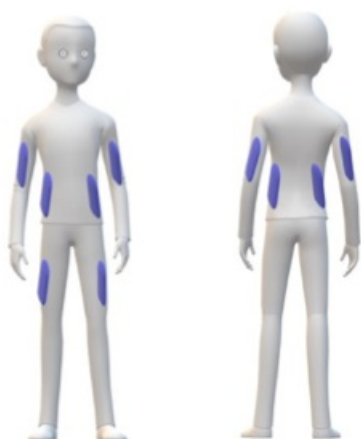
Fig. 6.1. Infusiones elastométricas.



Fig. 6.2. Bomba de infusión electrónica.



Fig. 6.3. Infusor mecánico de resorte flotante y bomba de inyección.



Mezclas

No se recomienda mezclar más de 3 fármacos, y han de ser compatibles (que no precipiten a temperatura ambiente).

Compatibilidad de mezclas de uso frecuente en infusor sc
Morfina + Haloperidol + Butilescopolamina
Morfina + Haloperidol + Midazolam
Morfina + Butilescopolamina + Midazolam
Morfina + Metoclopramida + Midazolam
Morfina + Levomepromazina + Midazolam
Consultar compatibilidad de mezclas en: http://www.pallcare.info/

Ventajas y desventajas

Ventajas	Desventajas
Segura	Absorción lenta y según hidratación
Sencilla, menos agresiva	Sólo pequeños volúmenes
Pequeños volúmenes concentrados	Limitación de fármacos y tipo de fluidos
Confortable, autonomía paciente	Contraindicada en algunas situaciones
Biodisponibilidad-efectividad similar a iv	
Ahorro gasto sanitario (menos ingresos)	

¡NO TE OLVIDES!

- Todo enfermo terminal tiene derecho a un cuidado paliativo adecuado, en el lugar que él elija.
- Para que el manejo del paciente en situación de últimos días sea en domicilio, es necesario: que sea su voluntad, y un buen soporte familiar, social y sanitario.
- La información y el empoderamiento de los pacientes y sus familias, facilitan y mejoran la atención del paciente en su domicilio.
- El equipo sanitario debe mostrarse proactivo, disponible y empático. Debe reevaluar con frecuencia al paciente así como apoyar al cuidador, adecuando el tratamiento a la situación clínica en cada momento.
- La vía sc es una vía excelente para el manejo del paciente terminal en domicilio. Permite la administración segura de los principales fármacos empleados (analgésicos, neurolépticos, sedantes, antieméticos, esteroides), así como la hidratación, si procede.

BIBLIOGRAFÍA

- Astudillo W., Mendiñeta C. ¿Dónde atender al enfermo en fase terminal: en casa o en el hospital? [monografía en internet]. Paliativos sin fronteras. Disponible en: <http://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/04-DONDE-ATENDER-AL-ENFERMO-EN-CASA-O-EN-EL-HOSPITAL-Astudillo-Mendiñeta.pdf>
- Gallardo Avilés R., Gamboa Antiñolo F. Uso de la vía subcutánea en cuidados paliativos [monografía en internet]. SECPAL. Disponible en: http://www.secpal.com//Documentos/Blog/monografia_secpal_04.pdf
- Losada Galván I., Sanz Trepiana L., Azcoitia Álvarez B. Principios Básicos en Cuidados Paliativos. En: D. Suarez Pita, J.C.Vargas Romero, J.Salas Jarque, I. Losada Galván, B. de Miguel Campo, P.M. Catalán Martín, B. Sánchez Moreno, M.A. Duarte Borges y I. Cabrera Rodrigo, editores. Manual de diagnóstico y terapéutica médica Hospital 12 de Octubre. 8º Ed. España. Acceso online: <https://profesionales.msd.es/login.xhtml>